

Syndrome de Goodpasture Sévère Compiqué d'Hémorragie Alvéolaire : De la Menace Vitale à la Dépendance à la Dialyse

F. Z. Maiza, H. Kheloufi, C. Boukhili, A. Bechiche, L. Krireche

Service de Néphrologie, CHU Saâdna Mohamed Abdenmour, Sétif

INTRODUCTION

Le syndrome de Goodpasture, ou maladie des anticorps anti-membrane basale glomérulaire (anti-MBG), est une affection auto-immune rare et potentiellement fatale caractérisée par l'association d'une glomérulonéphrite rapidement progressive (GNRP) et d'une hémorragie alvéolaire diffuse. Il représente une urgence médicale absolue dont le pronostic vital et fonctionnel dépend de la rapidité du diagnostic et de l'instauration précoce d'une immunothérapie agressive couplée aux échanges plasmatiques. Nous rapportons l'observation d'une forme grave admise dans notre structure.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

L'étude repose sur l'observation clinique et observationnelle d'un cas pris en charge dans le service de néphrologie du CHU de Sétif concernant une patiente âgée de 24 ans admise dans un tableau d'insuffisance rénale aiguë associée à une détresse respiratoire aiguë. Les explorations paracliniques initiales ont comporté un bilan biologique objectivant une altération de la fonction rénale avec une créatinine à 150 $\mu\text{mol/L}$ associée à un syndrome inflammatoire. Devant l'installation d'une hémoptysie et d'une dyspnée sévère, une imagerie thoracique par TDM a été mise en œuvre, objectivant des opacités alvéolaires bilatérales évocatrices d'une hémorragie alvéolaire. Enfin, l'immuno-analyse par le dosage des anticorps anti-MBG a montré des taux fortement positifs confirmant l'auto-immunité.

RÉSULTATS

La prise en charge thérapeutique a nécessité l'instauration en urgence d'un traitement combiné associant une corticothérapie lourde par bolus de méthylprednisolone à raison de 1 g par jour pendant 3 jours, dix séances d'échanges plasmatiques quotidiens pour l'épuration des auto-anticorps circulants, une biothérapie ciblée par deux bolus de Rituximab de 1 g espacés de 15 jours, ainsi qu'un recours immédiat à l'hémodialyse itérative en raison de la sévérité de l'atteinte rénale initiale. Sur le plan évolutif, on a observé une régression progressive de l'hémorragie alvéolaire et une stabilisation de la fonction respiratoire sur le plan pulmonaire. En revanche, l'évolution rénale a été marquée par l'absence de récupération de la fonction glomérulaire, conduisant la patiente à une insuffisance rénale chronique terminale rendue dépendante de l'hémodialyse chronique.

DISCUSSION

La présentation clinique de notre patiente illustre la classique et redoutable atteinte pneumo-rénale du syndrome de Goodpasture. L'atteinte rénale se manifeste typiquement par une glomérulonéphrite rapidement progressive avec des croissants extra-capillaires extensifs à la biopsie. La littérature confirme que si les échanges plasmatiques et les immunosuppresseurs permettent le sauvetage de la fonction respiratoire dans la majorité des cas, le pronostic rénal reste sombre lorsque le traitement est débuté à un stade avancé d'anurie ou d'insuffisance rénale sévère, le retard diagnostique initial constituant le principal facteur prédictif de progression vers l'hémodialyse définitive.

CONCLUSION

Le syndrome de Goodpasture demeure une urgence diagnostique et thérapeutique majeure. Seule une collaboration étroite entre cliniciens, biologistes et néphrologues, permettant une enquête immunologique rapide dès les premiers signes d'une atteinte mixte pulmonaire et rénale, peut améliorer le pronostic vital et épargner aux patients le recours lourd et définitif à l'hémodialyse chronique.